눈과 입이 계속 마를 때, 쇼그렌병을 확인하는 이유

증상과 혈액검사를 함께 보고 다음 진료를 정합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

눈마름·입마름도 류마티스 평가의 단서입니다

관절이 아프지 않아도 건조 증상을 여쭙는 이유가 있습니다

입마름·눈마름도 여쭙습니다

쇼그렌병에서도 류마티스 인자가 많이 양성으로 나옵니다. 그래서 관절 증상뿐 아니라 입마름, 눈마름 같은 건조 증상이 없는지 한 번쯤 살펴봅니다.

관절 증상이 없어도

류마티스 인자 양성으로 의뢰된 환자 중 관절 증상은 전혀 없지만 입마름·눈마름 증상으로 쇼그렌병 진단에 이르는 경우를, 연자는 가끔 경험한다고 합니다.



눈이 뻑뻑하고 입이 마른 두 가지 건조 증상을 나란히 보여 주는 설명용 그림

진료 때 눈과 입이 얼마나, 언제부터 마르는지 알려 주시면 검사 결과를 해석하는 데 도움이 됩니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

증상 확인에서 전문 진료까지 이어집니다

검사 결과는 증상과 함께 해석합니다

검사는 목적이 뚜렷할 때 시행합니다

자가항체 검사는 어떤 증상이 있는 상황에서 시행해야 결과를 해석하고 설명할 수 있습니다. 완벽한 혈액검사는 없기 때문입니다.

양성이면 전문 진료로 연결합니다

항핵항체가 양성이면 세부 항체(ENA) 검사를 해 볼 수 있습니다. 여기서도 양성이면 다양한 류마티스 질환을 시사하므로 류마티스내과로 연결합니다.



건조 증상 문진부터 혈액검사, 증상과 함께 해석, 필요할 때 전문 진료 연결까지의 네 단계

검사 결과 하나로 결론 내리지 않고, 증상과 함께 보고 다음 진료를 함께 정합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

자가항체 검사는 이렇게 세 가지를 봅니다

이름이 어려워도 무엇을 보는 검사인지만 알면 됩니다

류마티스 인자 (RF)

항체에 붙는 항체입니다. 이름과 달리 류마티스 관절염뿐 아니라 루푸스, 쇼그렌병 같은 여러 질환에서 양성이 나올 수 있어, 증상과 진료 상황을 함께 봅니다.

강의 표의 양성 비율

쇼그렌병 90%, 류마티스 관절염 80%, 루푸스 40%로 제시됐습니다.

항핵항체 (ANA)

세포 핵 성분에 반응하는 항체입니다. 루푸스를 선별하는 데 대표적으로 쓰이고, 쇼그렌병에서도 나타날 수 있습니다.

강의 표의 양성 비율

쇼그렌병 40~70%, 루푸스 95% 초과로 제시됐습니다.

ENA 항체 (항Ro·항La 등)

핵 속 항원 가운데 중요한 몇 가지를 따로 보는 검사입니다. 항Ro(SS-A)·항La(SS-B)는 쇼그렌병과 관련해 봅니다.

강의 표의 양성 비율

항SSA·항SSB는 쇼그렌증후군 75%, 루푸스 50%로 제시됐습니다.

세 검사 모두 양성이라는 결과만으로 병을 단정하지 않고, 증상과 함께 해석합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

류마티스 인자는 다른 이유로도 양성이 됩니다

양성이라는 결과만으로 병을 단정하지 않습니다

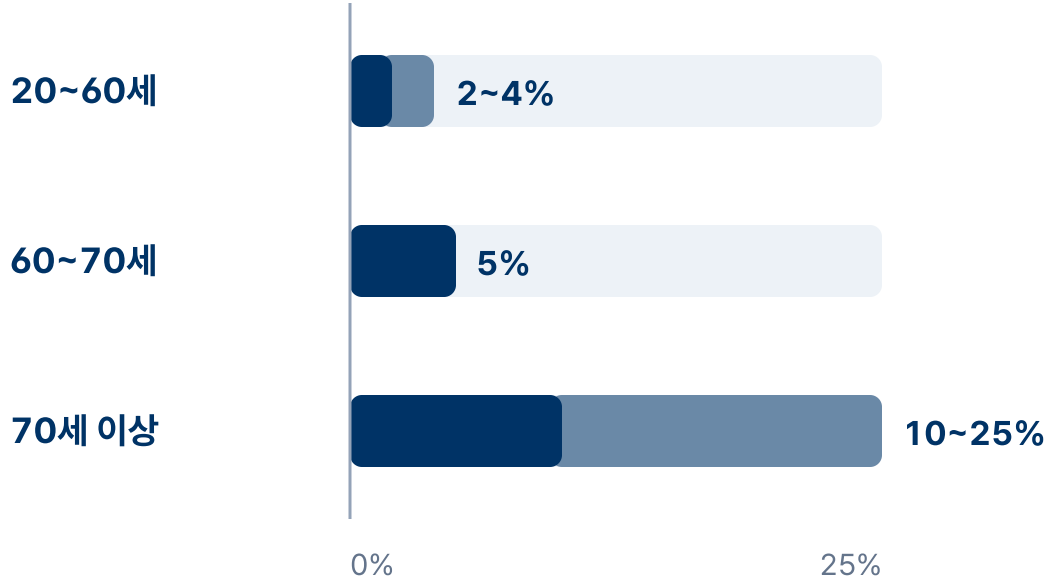
감염이 있을 때

AIDS, B형·C형 간염 같은 만성 바이러스 감염이나 결핵, 아급성 세균성 심내막염 같은 만성 세균 감염에서도 양성이 나올 수 있습니다.

건강한 사람에서도

연령이 높을수록 양성 비율이 올라갑니다. 연자는 60~70대에서 5%, 10~20% 이상까지도 양성일 수 있어 매우 비특이적인 검사라고 설명했습니다.

건강한 사람의 류마티스 인자 양성 비율



연령별 건강한 사람의 류마티스 인자 양성 비율(강의 표) · 설명용 도식

무작정 검사하면 오히려 진료에 혼선이 생길 만큼 특이도가 낮은 검사라고 연자는 설명했습니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

양성이어도 단정하지 않고, 음성이어도 놓지 않습니다

류마티스 관절염 설명에서 연자가 강조한 원칙입니다

류마티스 인자가 양성이면

류마티스 관절염이 의심될 때 진단 가능성은 올라갑니다. 그러나 양성이라는 결과만으로 류마티스 관절염을 진단할 수는 없습니다.

류마티스 인자가 음성이면

류마티스 관절염 환자의 20~30%는 류마티스 인자가 음성입니다. 그래서 음성이라고 해서 류마티스 관절염을 배제할 수도 없습니다.

완벽한 혈액검사는 없습니다. 검사 결과는 증상과 진찰 소견 안에서 해석합니다

관절이 붓는다면 류마티스 인자와 항CCP를 함께 봅니다

관절 통증만 있는지, 관절이 붓는지가 먼저입니다

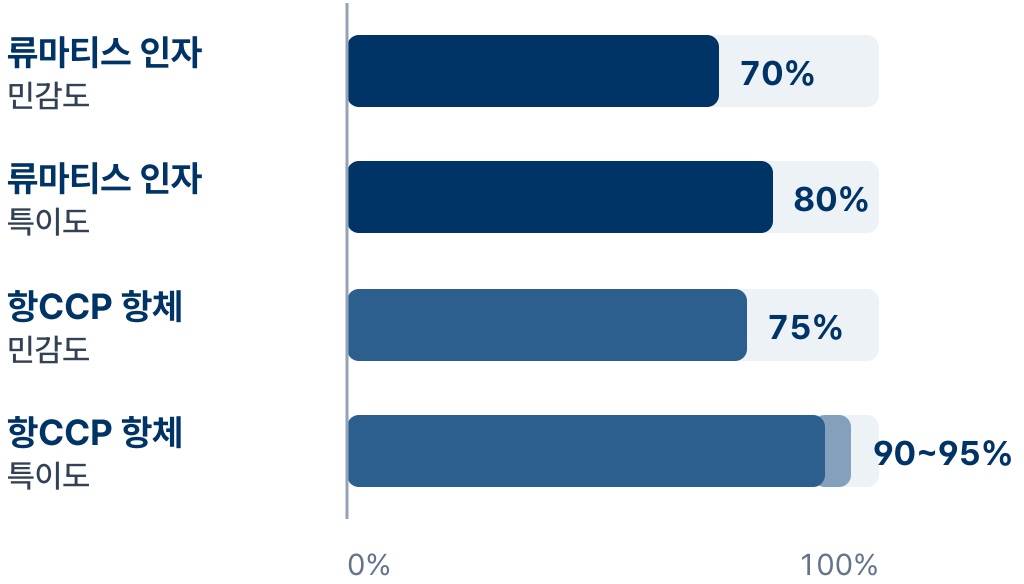
관절 부종이 뚜렷할 때 의미가 큽니다

연자는 이 검사들이 관절 통증만 있는 분이 아니라 관절 부종이 뚜렷한 분에서 해석할 의미가 있다고 설명했습니다.

항CCP는 더 특이적입니다

류마티스 인자 음성인 류마티스 관절염의 약 40%에서 항CCP가 양성입니다. 정상 상한의 3배 이상이면 높은 값으로 봅니다.

류마티스 관절염 진단에서의 검사 성능



민감도·특이도 비교(강의 표) · 설명용 도식

연자 Q&A: 6주 이상 이어지는 관절 부종은 검사가 정상이어도 류마티스내과 진료 의뢰가 필요할 것으로 본다고 답했습니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

항핵항체는 있는지보다 얼마나 높은지가 중요합니다

낮은 값은 건강한 사람에서도 흔히 나옵니다

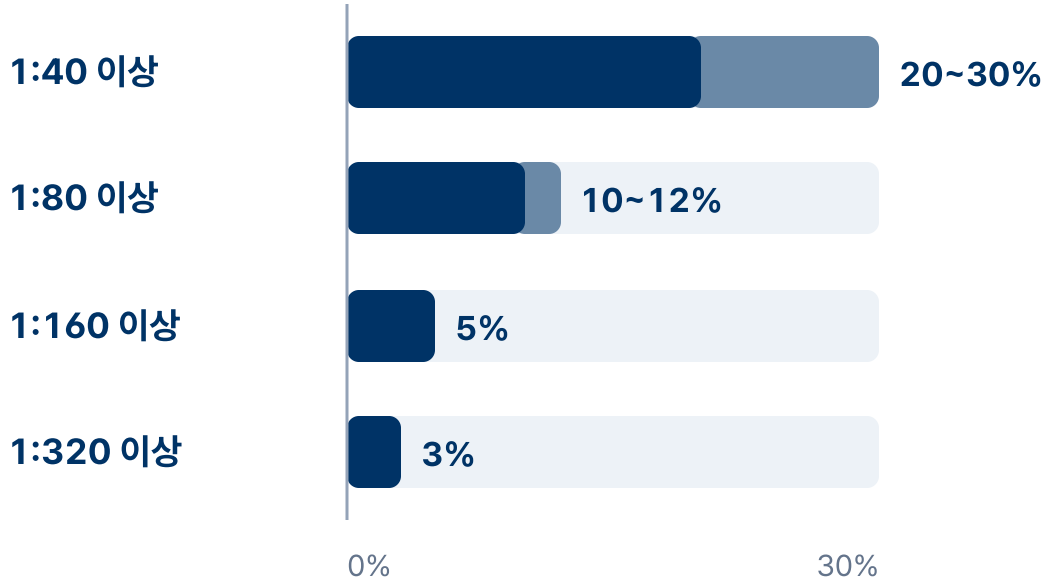
낮은 값은 흔합니다

건강한 성인도 약 5%에서 양성이고, 1:40 같은 낮은 titer(희석 배수)는 20~30%까지 나옵니다. 기준값은 문헌에 따라 1:80 또는 1:160으로 다릅니다.

정량검사로 시행합니다

있다·없다만 보고하는 정성검사는 의미가 거의 없어 titer를 보는 정량검사로 합니다. 염색 모양은 검사마다 달라 요즘은 titer를 더 중시합니다.

건강한 사람의 항핵항체 양성 비율



희석 배수별 건강한 사람의 항핵항체 양성 비율(강의 표) · 설명용 도식

연자 Q&A: ANA 1:80은 낮은 titer로 보며, 레이노 현상·관절염 같은 증상이 없다면 추적검사를 할 이유가 없다고 답했습니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

항핵항체 양성이 곧 류마티스 질환은 아닙니다

다른 질환이나 건강한 상태에서도 양성이 나올 수 있습니다

갑상선·간 질환, 감염, 암

자가면역 갑상선 질환, 위장관·간 질환, 감염, 악성 종양에서도 항핵항체가 양성일 수 있습니다.

C형 간염 연구

국내 C형 간염 환자의 약 32%에서 항핵항체가 양성이었고, 치료 후 음전되는 경우가 많다고 보고됐습니다.

증상 없이 양성이 이어지기도

높은 titer가 증상 없이 수년~수십 년 이어지는 분도 있습니다. 연자는 병을 일으키지 않는 몸의 자연 항체일 수 있다고 설명했습니다.

높은 값은 경과를 지켜봅니다

높은 titer라면 지금 류마티스 질환이 보이지 않아도 이후 결합조직질환이 생길 가능성이 있어 경과를 볼 수 있습니다.

> 낮은 값이든 높은 값이든 결과의 의미는 증상과 titer를 함께 보고 판단합니다

항핵항체가 음성이어도 쇼그렌이 의심되면 항Ro를 따로 봅니다

검사 방법 때문에 놓칠 수 있는 항체가 있습니다

왜 음성이 나올 수 있나요?

항핵항체 검사는 HEp-2라는 세포를 씁니다. 검사 과정에서 항원이 사라지거나, 핵이 아니라 세포질에 주로 있는 항원이면 음성으로 나올 수 있습니다.

쇼그렌이 의심될 때

연자는 쇼그렌이 의심되면 항핵항체가 음성이어도 항Ro 항체 검사를 따로 해 봐야 하는 경우가 있다고 설명했습니다.



항핵항체 검사가 음성이어도 쇼그렌이 의심되면 항Ro 항체 검사를 따로 해 볼 수 있음을 나란히 보여 주는 그림

눈·입마름이 계속된다면 항핵항체 결과와 별개로 항Ro 검사가 필요한지 진료에서 함께 정합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

ENA 검사는 핵 속 항체를 하나씩 나눠 봅니다

쇼그렌병과 관련해 보는 항체는 항Ro와 항La입니다

항Ro·항La는 쇼그렌병과 관련해 봅니다

항Ro(SS-A)는 건조 증후군(sicca syndrome)과 관련되고, 항La(SS-B)는 대개 항Ro와 함께 나타납니다. 쇼그렌증후군 환자의 약 75%에서 양성이었습니다. 항Ro는 항핵항체 음성 루푸스, 선천성 심장 차단을 동반한 신생아 루푸스와도 관련됩니다.

그 밖의 항체는 다른 질환과 관련됩니다

항dsDNA·항Sm은 루푸스에 특이적이고, 항dsDNA는 질병 활동성·신장염과 관련되어 경과를 추적하는 데 씁니다. 항RNP는 루푸스를 포함한 여러 류마티스 증후군의 겹침을 시사하며, 항Jo-1·항Scl-70·항센트로미어는 각각 염증성 근염, 전신 경화증 등과 관련됩니다.



핵 속 항원마다 짝이 되는 항체가 달라, ENA 검사는 이를 하나씩 나눠 본다는 설명용 그림

ENA 결과는 질병 활성도에 따라 변하지 않아 보통 반복해서 추적하지 않습니다. 항dsDNA는 루푸스에서 추적합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

항핵항체가 양성이면 손끝 색 변화를 여쭙니다

전문 진료로 연결할지 정하는 단서가 됩니다

레이노 현상

손끝이 추워지거나 찬물이 닿으면 노랗게·하얗게·파랗게 변했다가, 따뜻해지면 회복되는 현상입니다. 항핵항체 양성인 분에서 연자가 대표 증상 하나로 꼽았고, 있으면 류마티스 질환을 한 번쯤 생각해 봅니다.

다음 단계는 진료에서 정합니다

항핵항체가 양성이면 세부 항체(ENA) 검사를 해 볼 수 있습니다. 여기서도 양성이면 매우 다양한 류마티스 질환을 시사하고, 결과와 증상에 따라 류마티스내과 의뢰로 이어질 수 있습니다. 항체 이름을 모두 외우지 않으셔도 됩니다.



찬 곳에서 손끝 색이 변했다가 따뜻해지면 돌아오는 레이노 현상의 순서를 보여 주는 설명용 그림

손끝 색이 변하는 일이 있었다면 진료 때 꼭 말씀해 주세요

다른 검사도 같은 원칙으로 해석합니다

ANCA, HLA-B27, 그리고 증상과 무관하게 하는 검사

ANCA 항체

혈관염이 의심될 때 시행합니다. 양성이어도 곧 질병은 아니고, 혈관염이 있어도 모두 양성은 아닙니다. 심내막염, 염증성 장질환, 감염, 암, 약물에서도 양성이 나올 수 있습니다.

HLA-B27

척추관절염이 의심될 때 시행합니다. 일반 인구 대상 선별 검사로는 권고되지 않으며, 양성인 사람 중 척추관절염이 생기는 비율은 2~10% (약 5%)로 제시됐습니다.

? 증상 없이 하는 검사

강의에서 소개된 독일 성인 인구 연구에서는 증상과 무관하게 검사하면 항핵항체, 심지어 ANCA도 10% 이상에서 양성이었다고 합니다.

그래서 증상이 있는 임상 상황에서 검사해야 의미를 해석하고 설명할 수 있다고 연자는 강조했습니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

오늘 설명드린 핵심을 정리합니다

쇼그렌병을 확인하는 이유와 검사 결과를 읽는 원칙입니다

01

검사에는 목적이 있습니다

자가항체 검사는 증상 같은 임상 상황에서 시행해야 해석할 수 있고, 완벽한 혈액검사는 없습니다.

02

양성·음성 모두 단정하지 않습니다

류마티스 인자와 항핵항체는 특이도가 낮아 건강한 사람에서도, 다른 질환에서도 양성이 나옵니다.

03

높이(titer)를 함께 봅니다

항핵항체와 항CCP는 있는지보다 얼마나 높은지가 중요합니다.

04

쇼그렌이 의심되면 따로 봅니다

눈·입마름을 말씀해 주시면, 항핵항체가 음성이어도 항Ro 항체를 따로 검사할 수 있습니다.

결과는 증상과 함께 보고, 다음 진료는 진료실에서 함께 정합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

진료 때 이렇게 물어보세요

검사의 이유와 결과의 의미를 함께 이해하는 데 도움이 됩니다

01

이 검사를 왜 하나요?

눈·입마름 같은 증상과 연결해 어떤 목적으로 검사하는지 물어보세요.

02

결과의 높이는 어느 정도인가요?

양성·음성 여부와 함께 titer(수치)도 설명해 달라고 요청해 보세요.

03

항Ro 검사도 필요한가요?

항핵항체가 음성이어도 쇼그렌이 걱정된다면, 항Ro처럼 따로 하는 검사가 필요한지 물어보세요.

04

류마티스내과 진료가 필요한가요?

손끝 색 변화, 관절 부종 같은 다른 증상도 함께 알려 주세요.

궁금한 점은 진료 때 편하게 질문해 주세요

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

내 상태에 맞는 다음 진료를 함께 정합니다

증상과 검사 결과를 함께 보고 필요한 평가를 정합니다

전화

031-893-4560

주소

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,
4층 402-404호

진료시간

평일(월–금) 08:30~18:30
점심 13:00~14:00 · 토 08:30~13:30
일·공휴일 휴진

진료과

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

광교바른내과
진료 설명자료

광교바른내과 · 환자·보호자 설명자료